



5.11. Escala de Manía de Bech-Rafaelsen (MAS)

1

1. *Estado de ánimo elevado*
 1. Ausente
 2. Estado de ánimo dudoso o ligeramente elevado, pero todavía adaptado a la situación
 3. Estado de ánimo moderadamente elevado, bromea, se ríe
 4. Estado de ánimo marcadamente elevado, exuberante en los modos y el habla
 5. Estado de ánimo extremadamente elevado, no pertinente a la situación
2. *Actividad verbal (presión del habla)*
 1. Ausente
 2. Ligeramente verborreico
 3. Claramente verborreico, pocos intervalos espontáneos durante la conversación, aunque todavía no es difícil interrumpirla
 4. Prácticamente no existen intervalos espontáneos en la conversación, difícil de interrumpir
 5. Imposible interrumpir, domina completamente la conversación
3. *Contacto social incrementado (intrusividad)*
 1. Ausente
 2. Ligeramente o dudosamente entrometido (p. ej., interrumpe o es ligeramente intrusivo)
 3. Moderadamente entrometido y discutiendo o intrusivo
 4. Dominando, organizando, dirigiendo, pero todavía en contexto con la situación
 5. Dominando y manipulando extremadamente, fuera de contexto con la situación
4. *Actividad motora incrementada*
 1. Ausente
 2. Ligero incremento de la actividad motora (p. ej., tendencia a expresión facial viva)
 3. Actividad motora claramente incrementada (p. ej., expresión facial viva, incapaz de sentarse tranquilamente en una silla)
 4. Actividad motora excesiva, se mueve la mayor parte del tiempo, pero todavía puede permanecer sentado si se le pide (sólo se levanta una vez durante la entrevista)
 5. Constantemente activo, inquietamente energético. Incluso si se le pide, el paciente no puede permanecer sentado
5. *Alteraciones del sueño*

Este ítem hace referencia a la experiencia subjetiva del paciente sobre la duración del sueño (horas de sueño al día). La puntuación deberá basarse en las tres noches precedentes, con independencia de la administración de hipnóticos o sedantes. La puntuación es la media de las tres noches pasadas

 1. Ausente (duración del sueño habitual)
 2. Reducción de la duración del sueño hasta el 25 %
 3. Reducción de la duración del sueño hasta el 50 %
 4. Reducción de la duración del sueño hasta el 75 %
 5. No duerme
6. *Actividad social (distraibilidad)*

La actividad social debe medirse en términos de grado de discapacidad o interferencia con el funcionamiento social, laboral o con otras áreas importantes

 1. Ausente
 2. Motivación ligeramente incrementada, pero trabajo de calidad ligeramente inferior debido a la motivación cambiante; el paciente se distrae con cierta facilidad (la atención se dirige hacia estímulos irrelevantes)
 3. La actividad laboral está claramente afectada por la distraibilidad, pero todavía en un grado moderado
 4. El paciente ocasionalmente pierde el control sobre las tareas rutinarias debido a la distraibilidad marcada
 5. Incapaz de realizar cualquier tarea sin ayuda
7. *Hostilidad*
 1. Ausente
 2. Ligeramente impaciente o irritable, pero mantiene el control
 3. Moderadamente impaciente o irritable. No tolera provocaciones
 4. Provocador, realiza amenazas, pero puede ser calmado
 5. Violencia física patente, físicamente destructivo
8. *Actividad sexual incrementada*
 1. Ausente
 2. Incremento ligero del interés y la actividad sexual (p. ej., ligeramente flirteante)
 3. Incremento moderado del interés y la actividad sexual (p. ej., claramente flirteante)
 4. Incremento marcado del interés y la actividad sexual (p. ej., excesivamente flirteante)
 5. Completamente preocupado, absorto, en intereses sexuales

9. *Autoestima incrementada*
 1. Ausente
 2. Autoestima ligeramente incrementada (p. ej., sobreestima ligeramente sus capacidades habituales)
 3. Autoestima moderadamente incrementada (p. ej., sobreestima más claramente sus capacidades habituales o alude a habilidades inusuales)
 4. Ideas marcadamente irrealistas (p. ej., cree que posee habilidades, poderes o conocimientos, científicos, religiosos, etc., extraordinarios, pero puede lograrse que rectifique rápidamente)
 5. Ideas de grandiosidad que no pueden ser rectificadas
10. *Fuga de ideas*
 1. Ausente
 2. Descripciones ligeramente vívidas, explicaciones y elaboraciones sin perder el hilo conductor de la conversación. Los pensamientos son todavía coherentes
 3. Los pensamientos del paciente ocasionalmente son desviados por asociaciones aleatorias (ritmos, ruidos, juegos de palabras, estrofas de poemas o canciones)
 4. La línea del pensamiento es interrumpida con mayor regularidad por asociaciones desviadas
 5. Resulta muy difícil o imposible seguir al paciente debido a la fuga de ideas; salta constantemente de un tema a otro
11. *Nivel de ruido*
 1. Ausente
 2. Habla en tono ligeramente elevado, sin ser ruidoso
 3. Voz discernible a distancia y ligeramente ruidoso
 4. Vocífera, voz discernible a larga distancia, marcadamente ruidoso o canta
 5. Grita, da voces; o usa otras fuentes de ruido debido a ronquera